Douleur thoracique aiguë — Résumé

Appareil cardio-vasculaire — Sémiologie — Diagnostic étiologique (item 230)

Métadonnées

Version du prompt	v5.0
Date de génération	08/11/2026
Sources	Diapositives (21 p.) ; prise de notes (1 partie, 14 p.)
Périmètre	Cours entier

Légende : **bleu = notion clé** ; **orange = [Vigilance]/[Correction]** ; violet = [Incertain] ; vert = [Hors cours] (complément web) ; **gris = priorité des notes**.

Plan du cours

- 1. Définition et objectifs de la PEC (définition ; 4 étapes ; PIED ; 4P)
- 2. Identification de la gravité immédiate (constantes ; 3 axes)
- 3. Bilan clinique (interrogatoire : terrain, contexte, douleur ; examen physique ; score de Genève)
- 4. ECG des urgences CV (SCA ST+ / non ST+ ; DA ; EP ; péricardite) + examens quasi systématiques (troponines, RxT) et angioscanner
- 5. Sémiologie des urgences CV : SCA ; [SCC, notes seules] ; DA ; EP ; péricardite aiguë
- Conclusion

1. Définition & objectifs

Mots-clés
douleur thoracique aiguë; cou–ombilic; brutale; paroi; séreuses (plèvre, péricarde); cœur, aorte, œsophage; parenchyme pulmonaire non douloureux; 4 étapes; ECG 18 dérivations; PIED; 4P; UGD compliqué; pathologie biliaire infectieuse

DTA = douleur/gêne de la cage thoracique (cou → ombilic) de survenue **brutale**.

Fait mal : **paroi** (côtes, muscles), **séreuses** (plèvre, péricarde), **organes** (cœur, aorte, œsophage). **<!> Pas le parenchyme pulmonaire** (pas d'innervation sensitive).

4 étapes (contexte d'incertitude) : 1) **signes de gravité immédiate** ; 2) rechercher **PIED** ou urgence extracardiaque (interrogatoire + examen) ; 3) **ECG 18 dérivations** ; 4) PEC diagnostique et thérapeutique adaptée.

PIED (4 urgences CV) : **P**éricardite, **I**nfarctus (SCA), **E**mbolie pulmonaire, **D**issection aortique.

4P (non cardiaques) : **P**neumopathie infectieuse, **P**leurésie, **P**neumothorax, **P**ancréatite aiguë. + **UGD compliqué** (perforation), **pathologie biliaire infectieuse** (cholécystite, angiocholite).

2. Gravité immédiate

Mots-clés
constantes; PA aux 2 bras; FC; FR; SpO2; température; diurèse; hémodynamique; respiratoire; neurologique; marbrures; oligurie; tirage; BTA; hypercapnie; astérixis; Glasgow

Examen physique débute par les **constantes [Insistance]** : **PA aux 2 bras** (asymétrie), FC, FR, SpO2, T°, diurèse si hospitalisé.

3 axes :

- **Hémodynamique** : FC > 120/min, PAS < 90 mmHg, hypoperfusion périph. (marbrures, extrémités froides, oligurie). PAM < 65 **[Dit à l'oral]**.
- **Respiratoire** : FR > 25 ou < 10/min, SpO2 < 90 %, pauses, cyanose, tirage sus-sternal/sus-claviculaire, muscles accessoires, BTA, **hypercapnie** (HTA, sueurs, troubles conscience, astérixis, céphalées).
- **Neurologique** : angoisse, agitation, torpeur/coma (**Glasgow**).

=> gravité = mesures thérapeutiques avant/en parallèle du diagnostic.

3. Bilan clinique

Mots-clés
terrain; ATCD; FDRCV; MTEV; toxiques; POP; contexte; chirurgie/alitement/plâtre; néoplasie active; infection récente; traumatisme; début; circonstances; type; EN; localisation; irradiations; trinitro-sensible; durée/date/heure; mode évolutif; signes associés; auscultation; souffles; frottement; éclat B2; murmure vésiculaire; percussion; crépitants; signes droits; palpation; pouls 4 membres; score de Genève

Terrain : ATCD (cardio, broncho-pulm., digestifs, onco), **FDRCV** (proba a priori d'athérosclérose), FdR de **MTEV**, toxiques (cannabis, cocaïne, méthamphétamine), traitements (**POP** : regarder l'ordonnance ; risque ↑ si tabac).

Contexte : chirurgie / alitement / plâtre récents (MTEV), néoplasie active, **infection récente** (pleurésie, pneumopathie, péricardite virale), stress, traumatisme.

Douleur : début (brutal/progressif) ; circonstances (repos/effort) ; type (pique/brûle/serre ; question ouverte) ; intensité (EN) ; **localisation** : rétrosternale en barre → coronaire ; basithoracique → plèvre ; punctiforme → pariétale ; **transfixiante → pancréatite ou DA** ; irradiations : bras G/mâchoire → coronaire ; abdomen/dos → DA migratrice ; facteurs : respiration → séreuses, alimentation → ulcère ; **trinitro-sensible** (< 5 min) → coronaire ; **durée, date/heure +++** ; mode évolutif (↑ fréquence/intensité/durée = instabilité coronaire) ; signes associés : dyspnée, lipothymie/syncope, palpitations, pyrosis, nausées, vomissements, hématémèse.

[Vigilance] Calmée seulement à 15–20 min = non trinitro-sensible mais n'élimine pas le coronaire.

Auscultation cardiaque : tachycardie sinusale → EP ; **souffle systolique IM/CIV** → complication SCA ; **souffle diastolique IA → DA** ; **frottement → péricardite** (systolo-diastolique, persiste en apnée, « cuir neuf ») ; **éclat B2 pulmonaire → HTAP/EP**.

Auscultation pulmonaire : abolition murmure + VV → épanchement → percussion : **tympanisme = gaz** / **matité = liquide** ; **crépitants localisés → pneumopathie** ; **bilatéraux → IC gauche**.

Autres : signes d'IC droite (TJ/RHJ : EP, tamponnade) ; palpation reproduisant la douleur → **pariétale** ; pouls 4 membres, si asymétrie PA 4 membres (→ DA) ; palpation abdominale.

Score de Genève révisé [pas à apprendre par cœur — oral] : âge > 65, ATCD MTEV, chir./fracture < 1 mois, néoplasie, hémoptysie, douleur unilat. MI, FC 75–94 (1 pt), **FC ≥ 95 (2 pts)**, douleur palpation MI + œdème : 1 pt chacun. **0–1 faible (< 10 %) ; 2–4 intermédiaire (30–40 %) ; ≥ 5 forte (> 60 %)**.

4. ECG & examens complémentaires

Mots-clés
ECG 18 dérivations; 10 min; douleur persistante; SCA ST+; SCA non ST+; sus-décalage; miroir; sous-décalage ST; T négatives; sus-décalage transitoire; > 30 % normal; S1Q3; BBD; T(-) V1–V4; sus-décalage diffus concave; sous-décalage PQ; microvoltage; alternance électrique; FA; troponines ultrasensibles; radiographie thoracique; ligne de Damoiseau; PFLA; médiastin supérieur; angioscanner; hypodensité intraluminale; VD/VG > 1; flap intimal; faux chenal

ECG 18 dérivations dans les 10 min suivant le 1er contact médical si **douleur persistante**.

- **SCA ST+** : **ECG typique = clé du diagnostic** (sus-décalage ST, ex. V1–V3).
- **SCA non ST+** : **sous-décalage ST** = lésion sous-endocardique (V3–V6) ; **T négatives systématisées** = ischémie sous-épicardique (V1–V4/V5) ; sus-décalage transitoire possible ; **> 30 % ECG normal**.
- **DA** : ECG **le plus souvent normal** (sauf atteinte coronaire ; DA et SCA peuvent être intriqués).
- **EP** : peut être normal ; tachycardie sinusale ; **S1Q3** ; **BBD** (M en V1–V2) ; **T(-) V1–V4**.
- **Péricardite** : **sus-décalage ST diffus concave vers le haut** ; **sous-décalage PQ** (précoce) ; épanchement abondant : **microvoltage diffus, alternance électrique, FA**.

2 examens quasi systématiques : **troponines ultrasensibles** (nécrose des cardiomyocytes : ischémie, myocardite) et **radiographie thoracique** : pneumothorax complet D ; épanchement liquidien G (opacité + **ligne de Damoiseau**) ; **PFLA** sup. D (bactérienne) ; DA : **élargissement du médiastin supérieur**.

Angioscanner thoracique : intérêt majeur si suspicion d'**EP** (hypodensité intraluminale dans l'AP ; VD/VG > 1) ou de **DA** (type A [rang B] : dilatation aorte ascendante, **flap intimal**, **faux chenal** comprimant la vraie lumière).

5. Sémiologie des urgences CV

Mots-clés
SCA; FDRCV; douleur constrictive rétrosternale; examen normal; anémie (SCA type 2); RA; IM/CIV; BBG de novo; troponines; H0-H1/H0-H2; angor instable; coronarographie < 2 h / < 24 h; angioplastie; stent; SCC; DA; HTA; Marfan; Ehlers-Danlos; bicuspidie; anévrisme; douleur migratrice; asymétrie tensionnelle; D-dimères; angioscanner; ETO; EP; 3 formes cliniques; sine materia; syncope; TVP; Genève/Wells; cœur pulmonaire aigu; gazométrie; effet shunt; VPN > 95 %; ETT; péricardite; sujet jeune; contage; antéflexion; frottement; pouls paradoxal; tamponnade; myocardite; CRP; cœur en carafe; IRM gadolinium; critères ESC 2025

SCA

- **Terrain** : **FDRCV**. Douleur spontanée ou effort minime (angor d'effort préalable possible), **rétrosternale, constrictive**, irradiation mâchoire/bras ; atypies ; ST+ = douleur persistante.
- **Examen** : **le plus souvent normal** ; athérome (souffle carotidien/fémoral), HTA ; diag. diff. : **anémie** (SCA type 2), souffle de RA (± IA) ; complications : **souffle IM/CIV**, IC.
- **ECG** : ST+ : sus-décalage ST **≥ 2 dérivations d'un même territoire** + **miroir** ; ou **BBG de novo**. Non ST+ : normal > 30 %, sous-décalage ST, T(-), sus-décalage transitoire.
- **Biologie** : troponines US : ST+ **pas d'intérêt diagnostique** ; non ST+ : le plus souvent ↑, parfois cycle **H0-H1 / H0-H2**. **<!> Normales n'éliminent pas (angor instable) ; positives ne suffisent pas.** Éliminer une anémie.
- **RxT** : **non utile**. **Coronarographie** : **< 2 h** si ST+ ou non ST+ très haut risque ; **< 24 h** si non ST+ haut risque. Angioplastie : guide, thrombo-aspiration, **stent** **[oral]**.

[Incertain] **SCC (notes seules)** : douleur d'effort stable, cède à l'arrêt de l'effort ou < 5 min sous trinitrine ; ECG souvent normal entre crises ; GAJ, EAL ; tests d'ischémie (effort, écho-dobutamine, scintigraphie, TEP, IRM) ; coroscanner ou coronarographie.

Dissection aortique

- **Terrain** : **HTA ancienne** ± négligée, Marfan, Ehlers-Danlos, **bicuspidie**, anévrisme connu, ATCD chir. aortique, ATCD familial. Douleur **brutale, transfixiante, migratrice**, « déchirure / coup de poignard » ; symptômes neurovasculaires possibles.
- **Examen** : **asymétrie tensionnelle et des pouls (évocatrice mais pas systématique !)** ; ischémie aiguë de membre ; **souffle d'IA** ; déficit neuro, ischémie d'organe (rein, mésentère) ; tamponnade.
- **ECG** le plus souvent normal (ischémie si extension coronaire). **Bio** : **rien de spécifique** ; choc, collatérales ; **D-dimères possiblement ↑**. **RxT** : **élargissement du médiastin supérieur**.
- **Diagnostic positif** : **angioscanner thoracique** (rarement ETO) ; bilan pré-op : porte d'entrée, extension, collatérales.

Embolie pulmonaire

- **Terrain** : âgé, comorbidités, chirurgie/immobilisation, néoplasie, **COP + tabac**, ATCD MTEV.
- **3 formes** : **choc + signes droits + dyspnée** ; **dyspnée « sine materia »** ; **douleur basithoracique pleurale** (± toux, hémoptysie, fébricule). **Syncope = gravité.**
- **Examen** : peut être normal ; **tachypnée, tachycardie** ; éclat B2 ; TJ/RHJ ; crépitants (infarctus pulm. surinfecté) ; TVP **absente dans 30 %** ; **score Genève ou Wells**.
- **ECG** = **cœur pulmonaire aigu** : tachycardie sinusale, S1Q3, BBD, T(-) V1–V4.
- **Bio** : gazo : **hypoxémie** (PaO2 < 80), **hypocapnie** (PaCO2 < 35), **effet shunt** (somme < 120), alcalose respiratoire ; **D-dimères : VPP faible, VPN > 95 %**, utiles si proba non élevée ; troponines = **pronostic**.
- **RxT** souvent normale (hyperclarté, coupole surélevée, atélectasies en bandes). **Angioscanner ++** d'emblée si proba élevée, sinon si D-dimères ↑. Choc : **ETT** (dilatation VD, thrombus). Scintigraphie **[oral]**.

Péricardite aiguë

- Inflammation du péricarde, **le plus souvent virale**. **Terrain** : **sujet jeune sans FDRCV**, **contage infectieux**. Douleur constrictive/brûlure, **↑ inspiration profonde et décubitus, calmée par l'antéflexion**.
- **Examen** : fébricule/fièvre (38–38,5 °C) ; **frottement fugace et inconstant** ; complications (tamponnade) : BDC assourdis, TJ/RHJ, **pouls paradoxal**.
- **ECG** : sus-décalage ST diffus, sous-décalage PQ ; tamponnade : microvoltage, alternance ; myopéricardite : troubles du rythme ventriculaire.
- **Bio** : **troponines systématiques** (myocardite → mort subite) ; hyperleucocytose, **CRP ↑**. **RxT** : normale ; **« cœur en carafe »** si gros épanchement.

- **Écho systématique** (épanchement, tamponnade, dysfonction VG) ; coronarographie si myocardite suspectée (diag. diff. SCA) ; **IRM** : rehaussement tardif sous-épicardique au gadolinium (myocardite).
- **Diagnostic certain : symptomatologie compatible + ≥ 2 critères** (possible si 1) : frottement ; sus-décalage ST diffus ou sous-décalage PQ ; CRP ↑ ; épanchement (ETT/IRM), œdème ou rehaussement tardif en IRM (ESC 2025).

Conclusion

Motif **très fréquent**, présentation de nombreuses urgences vitales → **gravité d'abord**, puis **PIED** et **4P/UGD** ; **ECG 18 dérivations = prolongement systématique de l'examen** ; suite adaptée aux éléments recueillis.

Pièges / points corrigés
[Correction] Troponine = **protéine** de la contraction, pas une enzyme.
[Correction] ST+ = sus-décalage ; le **miroir = sous-décalage** dans les dérivations opposées ; référence = ligne isoélectrique.
[Correction] Tronc artériel brachio-céphalique : un seul, **à droite**.
[Correction] ETO = **trans-œsophagienne** (≠ ETT trans-thoracique ; erreur de l'objectif n°11).
[Correction] RA = rétrécissement **aortique** (valve).
[Correction] Épanchement liquidien = **opacité** (pas hyperclarté).
[Correction] DA = déchirure de l'**intima** + clivage de la média.
[Correction] EP : **hypoxémie** (sang) ≠ hypoxie (tissus).
<!> ECG normal n'élimine ni SCA non ST+ (> 30 %), ni EP, ni DA.
<!> Troponines inutiles au diagnostic du ST+ ; normales n'éliminent pas un SCA.
<!> RxT non utile au diagnostic de SCA.
<!> Asymétrie tensionnelle : évocatrice de DA mais inconstante.
<!> Frottement péricardique fugace et inconstant ; TVP absente dans 30 % des EP.
<!> Le parenchyme pulmonaire ne fait pas mal.

À ne pas confondre
Sous-décalage ST (lésion sous-endocardique) ≠ **T négatives** (ischémie sous-épicardique).
Sus-décalage systématisé + miroir (SCA ST+) ≠ **sus-décalage diffus concave + sous-décalage PQ** (péricardite).
Coronarographie < 2 h (ST+, non ST+ très haut risque) ≠ **< 24 h** (non ST+ haut risque).
Tympanisme (gaz, pneumothorax) ≠ **matité** (liquide, pleurésie).
Crépitants localisés (pneumopathie) ≠ **bilatéraux** (IC gauche).
Signes droits : EP (↑ postcharge VD) ou tamponnade (compression).
D-dimères : exclusion (VPN) de MTEV ; peuvent aussi ↑ dans la DA.
Troponines : diagnostic (SCA non ST+) ≠ pronostic (EP) ≠ recherche de myocardite (péricardite).
PIED (cardiovasculaires) ≠ **4P** (non cardiaques).

Tableaux comparatifs

Objectif : distinguer les 4 urgences cardiovasculaires à rechercher systématiquement devant toute DTA, selon les mêmes étapes (interrogatoire, examen, ECG, biologie, imagerie). Cible commune : ne pas méconnaître une urgence vitale.

01 URGENCES CARDIOVASCULAIRES (PIED)							
Élément	**Terrain / contexte**	**Douleur**	**Examen physique**	**ECG**	**Biologie**	**Radio thoracique**	**Examen clé / autres**
SCA ST+ *Occlusion complète → ST+ systématisé + miroir ; troponines inutiles, coro < 2 h*	FDRCV	Rétrosternale, constrictive, spontanée ou effort minime ; irradiation mâchoire/bras ; **persistante**	Le plus souvent **normal** ; athérome, HTA ; diag. diff. anémie, RA ; complic. : souffle IM/CIV, IC	**Typique** : sus-décalage ST ≥ 2 dérivations d'un territoire + miroir ; ou BBG de novo	Troponines US : **pas d'intérêt diagnostique** ; éliminer anémie	Non utile	**Coronarographie < 2 h**
SCA non ST+ *Sub-occlusion → ECG normal > 30 % ; troponines (cycle H0-H1/H2) ; coro < 2 h ou < 24 h*				Normal > 30 % ; sous-décalage ST ; T(-) ; sus-décalage transitoire	Le plus souvent ↑ ; cycle H0-H1 / H0-H2 ; <!> normal n'élimine pas (angor instable)		Coro < 2 h si très haut risque ; **< 24 h** si haut risque
Dissection aortique *« Déchirure qui migre » : transfixiante + asymétrie ; ECG normal ; médiastin large*	HTA ancienne ± négligée ; Marfan, Ehlers-Danlos ; bicuspidie, anévrisme ; ATCD chir. aortique, familial	**Brutale, transfixiante, migratrice**, déchirure / coup de poignard ; irradiation dos/abdomen	**Asymétrie PA et pouls** (<!> inconstante) ; souffle d'**IA** ; ischémie membre/organe ; déficit neuro ; tamponnade	**Le plus souvent normal** ; ischémie si extension coronaire	**Rien de spécifique** ; D-dimères possiblement ↑ ; anomalies de choc	**Élargissement du médiastin supérieur**	**Angioscanner** (flap intimal, faux chenal) ; rarement ETO ; bilan pré-op
Embolie pulmonaire *Caillot AP → cœur droit : S1Q3, tachycardie ; D-dimères VPN ; angioscanner*	Âgé, comorbidités, chirurgie/immobilisation, néoplasie, COP + tabac, ATCD MTEV	Basithoracique de type pleural ; ou choc + signes droits ; ou dyspnée sine materia ; syncope = gravité	Peut être normal ; **tachypnée, tachycardie** ; éclat B2 ; TJ/RHJ ; crépitants ; TVP (absente 30 %) ; Genève/Wells	Cœur pulmonaire aigu : tachycardie sinusale, **S1Q3**, BBD, T(-) V1–V4 ; peut être normal	Gazo : hypoxémie, hypocapnie, effet shunt, alcalose ; **D-dimères VPN > 95 %** ; troponines = pronostic	Souvent normale ; hyperclarté, coupole surélevée, atélectasies en bandes	**Angioscanner** (proba élevée ou D-dimères ↑) ; ETT si choc ; VD/VG > 1
Péricardite aiguë *Jeune + virus + douleur ↑ inspiration, ↓ penché en avant ; ST diffus + PQ ↓*	**Sujet jeune**, sans FDRCV ; contage infectieux récent (viral)	Constrictive ou brûlure, **↑ inspiration profonde et décubitus, ↓ antéflexion**	Fébricule/fièvre 38–38,5 °C ; **frottement** (fugace, inconstant) ; tamponnade : BDC assourdis, TJ/RHJ, pouls paradoxal	**Sus-décalage ST diffus concave** ; **sous-décalage PQ** ; tamponnade : microvoltage, alternance	**Troponines systématiques** (myocardite) ; hyperleucocytose ; **CRP ↑**	Normale ; « cœur en carafe » si épanchement abondant	**Échocardiographie systématique** ; IRM (gadolinium) si myocardite ; ≥ 2 critères ESC 2025

Repère : ECG **normal possible** dans SCA non ST+, DA et EP ; **sus-décalage systématisé + miroir** (SCA ST+) ≠ **diffus concave + PQ ↓** (péricardite). Troponines : inutiles au diagnostic du ST+, pronostiques dans l'EP, recherche de myocardite dans la péricardite. **Angioscanner** = DA et EP ; **échocardiographie** = péricardite ; **coronarographie** = SCA. D-dimères : EP (VPN) mais aussi ↑ possible dans la DA.

Objectif : reconnaître les causes non cardiaques à rechercher systématiquement (« 4P ») et les causes digestives rarement graves mais possiblement compliquées. Cible commune : interrogatoire + examen physique + radio thoracique.

02 URGENCES NON CARDIAQUES (4P, UGD, BILIAIRE)				
Élément	**Contexte / douleur**	**Auscultation / percussion / palpation**	**Radio thoracique**	**Particularité**
Pneumopathie infectieuse *Infection + crépitants localisés*	Épisode infectieux récent	**Râles crépitants localisés** (± inflammation pleurale)	PFLA : opacité lobaire (ex. sup. D), origine bactérienne	
Pleurésie *Douleur basithoracique + matité*	Épisode infectieux récent (pleurésie infectieuse) ; douleur **basithoracique**, rythmée par la respiration	Abolition murmure vésiculaire et VV ; **matité** (liquide)	Opacité basale limitée par la **ligne de Damoiseau**	
Pneumothorax *Air → abolition + tympanisme*		Abolition murmure vésiculaire et VV ; **tympanisme** (gaz)	Pneumothorax complet : poumon rétracté vers le hile	
Pancréatite aiguë *Transfixiante comme la DA*	Douleur **transfixiante**	Palpation abdominale		<!> Diagnostic différentiel de la DA (douleur transfixiante)
UGD compliqué *Douleur liée aux repas*	Douleur rythmée par l'**alimentation**	Palpation abdominale		Rarement grave, mais complication possible (perforation)
Pathologie biliaire infectieuse *Cholécystite / angiocholite*		Palpation abdominale		Peut se compliquer si non traitée

Repère : Abolition du murmure vésiculaire : **matité = liquide (pleurésie)**, **tympanisme = air (pneumothorax)**. Crépitants **localisés** = pneumopathie (bilatéraux = IC gauche). Douleur **transfixiante** : pancréatite ou DA.

Objectif : relier chaque signe d'examen cardiaque à l'urgence qu'il évoque. Cible commune : auscultation cardiaque systématique devant une DTA.

03 SIGNES D'AUSCULTATION ET SIGNES DROITS			
Signe	**Temps / caractère**	**Évoque**	**Contexte / piège**
Souffle systolique *IM ou CIV = SCA compliqué*	Systolique	**IM ou CIV** : complication d'un SCA vu tardivement	Diagnostic différentiel : **rétrécissement aortique**
Souffle diastolique *Diastole = IA = DA*	Diastolique	**Insuffisance aortique → dissection aortique**	Urgence diagnostique majeure
Frottement péricardique *« Cuir neuf » qui persiste en apnée*	Systolo-diastolique, persiste en apnée, « cuir neuf »	**Péricardite aiguë** (quasi pathognomonique)	<!> Fugace et inconstant ; possible aussi dans un épanchement de SCA ou de DA
Éclat du B2 pulmonaire *B2 fort = HTAP*	2e bruit renforcé au foyer pulmonaire	**HTAP / EP**	
Tachycardie sinusale *Fréquente mais non spécifique*	Rythme rapide sinusal	**EP** (un des signes les plus courants)	Non spécifique
Signes droits (TJ, RHJ) *Cœur droit en souffrance*	—	**EP** (↑ postcharge VD) ou **tamponnade**	Dans la péricardite : signe de complication

Repère : Systolique = **complication de SCA** (IM/CIV) ; diastolique = **DA** (IA) ; systolo-diastolique persistant en apnée = **péricardite** ; éclat B2 = **EP/HTAP**.

Objectif : distinguer l'atteinte coronaire aiguë (urgence) de la forme chronique stable. Cible commune : terrain FDRCV, douleur rétrosternale constrictive irradiant à la mâchoire et au bras.

04 SYNDROME CORONARIEN AIGU VS CHRONIQUE					
Élément	**Douleur**	**Trinitrine**	**ECG**	**Biologie**	**Examens**
SCA *Douleur de repos / effort minime, persistante → troponines*	Spontanée ou effort minime ; ST+ = persistante		ST+ typique ou non ST+ (normal > 30 %)	Troponines US (non ST+)	Coronarographie < 2 h / < 24 h
SCC [Incertain, notes seules] *Effort, stable, cède au repos*	À l'effort, cède à l'arrêt de l'effort ; stable dans le temps	Cède en < 5 min (sublinguale)	Le plus souvent normal entre les crises ; séquelle d'infarctus possible	Anémie ; GAJ, EAL	Tests d'ischémie ; coroscanner ou coronarographie

Repère : SCA = douleur **de repos ou d'effort minime**, aggravation (instabilité) ; SCC = douleur **d'effort stable**, trinitro-sensible < 5 min. Un épisode de plus en plus fréquent/intense/prolongé = instabilité → SCA.